SUPSI

I cambiamenti dei concetti, dei modelli interpretativi della disabilità e le sue classificazioni

Chiara Balerna,Michela Luraschi, Donatella Oggier-Fusi, Piercarla Reposo

Percorsi nelle disabilità

Esclusione
Separazione
Integrazione

Inclusione
Per una vita
senza barriere
pro infirmis

Evoluzione delle forme istituzionali della considerazione delle persone con disabilità in ambito educativo (in Mainardi 2010)

- **L'assenza d'attenzione**: l'esclusione / la ghettizzazione; l'educazione è un lusso/ un muro separa quelli che possono beneficiare dell'educazione e gli altri.
- **La segregazione**: la considerazione coincide con luoghi speciali. Tra le idee di fondo: vantaggio della ripartizione dei compiti in funzione di un criterio di « omogeneità » dei « gruppi » /differenziazione strutturale / specializzazione.
- **L'integrazione:** ad attenzioni speciali non coincidono necessariamente luoghi speciali; l'integrazione è dell'ordine delle possibilità come pure la differenziazione interna ai contesti e alle situazioni.
- **L'inclusione**: ad attenzioni « normalmente speciali » coincidono luoghi usuali. L'educazione è rivolta a tutti senza eccezioni e senza proclamare la necessità di una ripartizione del lavoro o della costituzione di gruppi sulla base di nessun tipo di criterio (abilità, genere, appartenenza etnica, razza, prima lingua, classe sociale, orientamento sessuale, religione, ecc.).

I luoghi delle attenzioni e i processi nella storia:

In: Mainardi (2010)

«L’aggettivo inclusivo, più adeguato e pertinente, esprime chiaramente un doppio rifiuto. Da una parte, quello di una società e di strutture, dalla prima infanzia all’adolescenza e dall’età adulta alla vecchiaia, di cui solo le persone “non disabili” si sentirebbero proprietarie, con lo scopo di farne un loro privilegio o usarle per i propri piaceri personali, secondo le parole di Montesquieu e di Rousseau. Dall’altra, il rifiuto della marginalizzazione, in luoghi improponibili, di tutti quelli che vengono giudicati imbarazzanti, diversi, incompatibili. Se tutto ciò non viene ridotto a un luogo comune che si oppone, senza giustificazione, al termine integrazione, le due ottiche sono tuttavia totalmente distinte. L’obiettivo dell’integrazione è di fare entrare in un insieme, di incorporare. Si tratta di procedere, come si dice in astronautica, all’assembramento delle diverse parti costitutive di un sistema, facendo attenzione alle loro compatibilità e al buon funzionamento dell’insieme. Un elemento esterno, inserito dentro, deve adattarsi a un sistema preesistente. Ciò che avviene principalmente è l’adattamento della persona: se spera di potersi integrare deve, in un modo molto simile all’assimilazione, trasformarsi, normalizzarsi, adattarsi o riadattarsi. Per contro, un’organizzazione sociale è inclusiva quando sa modulare il proprio funzionamento, quando diventa flessibile per offrire a tutti un luogo in cui sentirsi a casa. Questo senza neutralizzare i bisogni, i desideri e i singoli destini ma piuttosto riassorbendoli nel tutto.»

Gardou, 2016, pp.34-35

Integrazione e inclusione

Realizzare una rampa per consentire ad uno specifico studente l'accesso alle aule è una risposta attiva che nella sua eccezionalità chiama in gioco implicitamente (1) la responsabilità individuale dell'allievo, l'attesa personale di modifiche dell'organizzazione scolastica, ossia il diritto a negoziare condizioni particolari d'accompagnamento e (2) la capacità della "nicchia" di rispondere a tale richiesta di adattamento: un'eccezione istituzionale (dell'ordine della possibilità).

Un assimilazione/accomodazione puntuale soggettivamente imposta e soggettivamente raccolta: così come lo sarebbe il dover richiedere costantemente a un docente di fare la cortesia quasi personale di non parlare con le spalle alla classe e al docente di accogliere tale richiesta.

Misura speciale, eccezionale ma possibile

Integrazione e inclusione

Predisporre rampe d'accesso indipendentemente dalla presenza o meno a scuola di studenti che abbisognino direttamente di quest'ausilio, è una misura inclusiva (una misura istituzionale tesa a garantire accessibilità).

Preoccuparsi di rivolgersi agli studenti come se alcuni di loro fossero audiolesi, quindi non girando la schiena all'interlocutore, è un'attenzione speciale così come lo è lo spiegare uno schema a parole con la cura necessaria per renderlo evidente e accessibile anche a chi non vede (a causa di un problema sensoriale o che, pur vedendo, fatica a cogliere le peculiarità dell'immagine).

Un'assimilazione/accomodazione diffusa e diffusamente recepita come normale: com'è il caso per i servizi pubblici, i parcheggi, ecc…

Misure speciali ma non eccezionali (normalmente speciali)

«La prospettiva inclusiva, basata sull'equità, la libertà e le possibilità, implica un accesso naturale, libero ed equo, a tutto e per tutti. Un'accessibilità multidimensionale e universale. Lungi dal limitarsi all'ambiente naturale o costruito dall'uomo (scalinate meno alte, ascensori adattati, ingressi più larghi…), agli spazi pubblici in generale, ai trasporti o agli alloggi, si allarga direttamente ai temi dell'educazione, del lavoro, dell'occupazione, della cultura, dell'arte, del tempo libero, dell'informazione e della comunicazione: tutta la vita economica, comunitaria, sociale e civile è implicata.»

C. Gardou, 2016, pp.131-132

Esempi

- *Misura speciale, eccezionale ma possibile*

- Misure speciali ma non eccezionali (normalmente speciali)

Non solo

…nell'accessibilità all'ambiente naturale o costruito

ma anche

…educazione

…informazione

…comunicazione

…cultura

…tempo libero

ecc.

«Possiamo affermare, dunque, che l’inclusione non riguarda più questa o quella categoria di cittadini: non ha più senso parlare di inclusione di persone con disabilità, con problematiche psichiatriche, di persone immigrate e così via (…) è preferibile ribadire che l’inclusione si riferisce a una serie di importanti condizioni che debbono caratterizzare i contesti di vita di tutti affinché vengano rispettati i loro diritti e considerate con attenzione le loro aspettative, necessità e richieste. Se un contesto, in altri termini, risulta accogliente, tollerante o solidale solo nei confronti di alcune persone, tende di fatto a essere poco rispettoso delle differenze e, proprio per questo, non può definirsi inclusivo»

Di Maggio, Nota, Soresi, 2016, p.180

«Gli adattamenti non si limitano a un’azione specifica per dei gruppi ritenuti specifici. Mirano a migliorare il benessere di tutti. Che siano architettonici, sociali, educativi, pedagogici, professionali o culturali, i piani inclinati sono universalmente positivi. Ciò che facilita gli uni è benefico per tutti gli altri. (…) non è una necessità esclusivamente legata alla sola disabilità: si tratta di un investimento globale. Ciò che è predominante è l’azione sul contesto per renderlo favorevole a tutti, al fine di esprimere concretamente a ogni membro della società: ciò che fa la tua singolarità (la tua età, la tua identità o il tuo orientamento sessuale, le tue caratteristiche genetiche, le tue appartenenze culturali e sociali, le tue opinioni politiche e non, le tue potenzialità, le tue difficoltà o il tuo handicap) non può privarti del diritto di godere dell’insieme dei beni collettivi e sociali. Questi non sono la prerogativa di nessuno. Nessuno ha l’esclusività del patrimonio umano e sociale: ecco il primo pilastro della società inclusiva.»

C. Gardou, 2016

Esercizio in seminario

Una persona su una sedia a rotelle si trova ai piedi della scala ma non può accedere al seggio elettorale: perché?

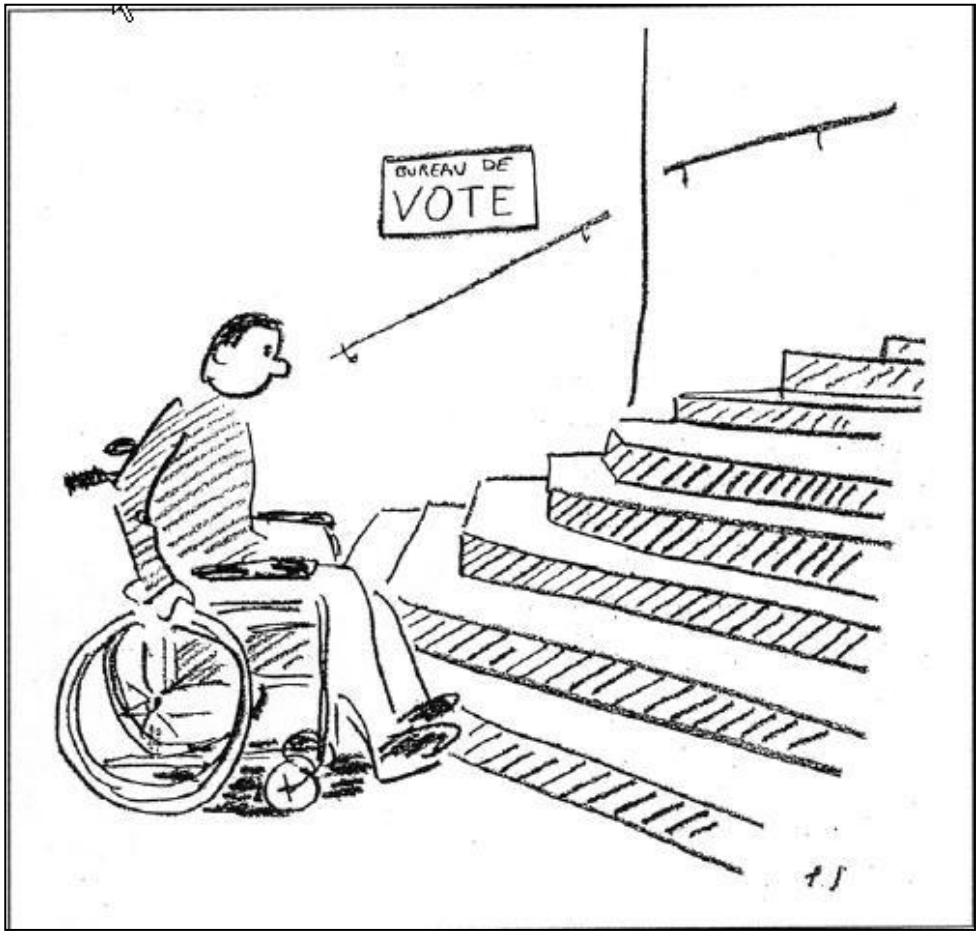
(Non guardare la slide successiva) e prova a immaginarti quali letture della situazione potresti dare

a.

b.

c.

d.



Una persona su una sedia a rotelle si trova ai piedi della scala ma non può accedere al seggio elettorale: perché?

- POSSIBILI RISPOSTE

- Modello individuale:
- *perchè ha un danno alla spina dorsale* (modello biomedico)
- *perchè non può camminare* (modello funzionale o riabilitativo)

- Modello sociale:
- *a causa della scala, una barriera architettonica* (modello ambientale)
- *per un'esclusione sociale o una situazione di discriminazione* (modello civico dei diritti umani).

Definizione CDPD

- (e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.

Il mutamento del concetto di disabilità

Partendo dai movimenti che abbiamo in parte visto nelle scorse lezioni possiamo intuire un cambio importante nell'approccio alla disabilità, sentiamo infatti parlare di diritto alla partecipazione, di non discriminazione, di inclusione.

- Attraverso la spinta dei movimenti associativi
- Attraverso il mutamento delle rappresentazione della disabilità
- Attraverso l'evoluzione internazionale dell'interpretazione del concetto di **handicap/disabilità**

La disabilità un termine che raggruppa un grande complessità e che può coinvolgere chiunque

- *Artificialmente possiamo riconoscere i seguenti "gruppi"*
  - *Persone anziane che perdono la loro indipendenza/autonomia*
  - *Persone con un deficit sensoriale o motorio*
  - *Persone con un deficit cognitivo*
  - *Persone che hanno subito un trauma/danno a seguito di ferite di guerra, di malattie, incidenti sul lavoro, incidenti a domicilio, incidenti del traffico*
  - *Persone con problemi di salute mentale*
  - *Persone con disturbi cronici*

La disabilità un termine che raggruppa un grande complessità e che può coinvolgere chiunque

5 target:

- Fisico
- Mentale
- Psichico
- Sensoriale
- Da dipendenza

- Congenito (dalla nascita)
- Acquisito

La disabilità un termine che raggruppa un grande complessità e che può coinvolgere chiunque

- primo rapporto mondiale sulla disabilità realizzato da Organizzazione mondiale della sanità e Banca mondiale nel giugno 2011 indicava che le persone che vivono con qualche forma di disabilità sono oltre un miliardo, circa il 15% della popolazione mondiale. Aumenta la popolazione mondiale, ma in proporzione la disabilità colpisce più persone, aumenta di più. Per questa ragione, per rendere conto, attraverso un'immagine, dell'impatto della disabilità ho usato l'espressione Terza nazione del mondo (2009): messe tutte insieme, oggi, le persone con disabilità costituirebbero una nazione che, per popolazione, verrebbe dopo Cina e India. (Schianchi 2016 p. 266)

- su una popolazione mondiale di 7 miliardi, più di un miliardo vive in situazione di disabilità. Se includiamo i loro familiari – genitori, fratelli e coniugi – quotidianamente implicati, più di un terzo degli abitanti del pianeta vi si trova coinvolto in modo diretto o indiretto. Questa cifra non cala. Al contrario, aumenta di pari passo con lo sviluppo demografico mondiale (3 miliardi di abitanti nel 1960; 4,5 nel 1980; 6 nel 2000), con i progressi in campo sanitario, con il miglioramento delle cure neonatali e l'allungamento della speranza di vita. Aumenta anche a causa dei conflitti armati (Gardou, 2016)

La disabilità un termine che raggruppa un grande complessità e che può coinvolgere chiunque

- Nei paesi dove la speranza di vita supera i settant'anni, una persona passa in media otto anni della sua esistenza in condizione di disabilità, che sia in seguito a un deficit fisico, sensoriale oppure a un disturbo mentale, cognitivo o psichico, congenito o acquisito. (Gardou, 2016, p.70)

- in Svizzera vivono circa 1,8 milioni di persone con disabilità, di cui 70'000 in Ticino (Risoluzione della sessione cantonale delle persone con disabilità, 2024)

Handicap, termine “cappello” per la disabilità

- Invalido (legato all’ambito della riabilitazione e dell’inserimento sociale): fine anni ’70
- Handicappato (concetto di integrazione): fine anni ’80
- Persona disabile (concetto di partecipazione): fine anni ‘90
- Persona con disabilità / persona in situazione di handicap (inclusione come diritto): dal 2000

Esprimersi diversamente

Obiettivi delle classificazioni dell'ONU promosse attraverso l'OMS.

- A partire dalla seconda metà del secolo scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato differenti strumenti di classificazione inerenti l'osservazione e l'analisi delle patologie organiche, psichiche e comportamentali delle popolazioni, al fine di migliorare la qualità della diagnosi di tali patologie. Queste classificazioni servono quindi alla valutazione dello stato di salute della popolazione e orientano l'efficacia dei servizi della salute attraverso codici uniformi.

- andremo a vedere tre delle principali classificazioni emanate dall'ONU (ICD, ICDH e ICF) e ne leggeremo le differenze e le conseguenze nel contesto della disabilità ed evidenzieremo come le classificazioni sono mutate grazie ai cambiamenti nel mondo della disabilità

Il modello della riabilitazione

- Dopo la seconda guerra mondiale e fino alle fine degli anni ’70 i testi e le leggi erano tutti orientati verso il recupero e la riabilitazione delle persone invalide con l’obiettivo di reinserirle nel mondo del lavoro offrendo delle protesi.

- dagli anni 70, vi sono due elementi importanti che mettono in crisi questo sistema: da una parte il progresso della medicina e l’apparizione di malattie croniche che non permettono quindi un pieno recupero, dall’altra l’invecchiamento della popolazione che la rende in generale più fragile.
- Da notare come il modello della riabilitazione sia legato ad una norma da riacquistare con delle protesi che colmino una mancanza.
- In questa lettura si inserisce la classificazione ICD

La Classificazione Internazionale delle malattie, ICD (International Classification of Disabilities)

- risponde all'esigenza di cogliere la causa delle patologie, fornendo per ogni sindrome e disturbo una descrizione delle principali caratteristiche cliniche e indicazioni diagnostiche.

- **EZIOLOGIA → PATOLOGIA → MANIFESTAZIONE CLINICA**

L'ICD, oggi.

- Non comprende le conseguenze della malattia ma "unicamente le cause"
- Utilizzo complementare alle classificazioni attuali, attualmente è molto simile al DSM
- Siamo alla versione ICD 11

La Classificazione Internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap (ICIDH, 1980).

- L'ICIDH non coglie la causa della patologia, ma l'importanza e l'influenza che il contesto ambientale esercita sullo stato di salute delle popolazioni
- L'ICIDH si concentra sulle conseguenze della patologia
- L'ICIDH introduce il contesto di confronto con l'ambiente (in parte)
- **MALATTIA O DISTURBO → MENOMAZIONI → DISABILITÀ → HANDICAP**

La Classificazione Internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap (ICIDH, 1980).

- I tre concetti alla base dell'ICIDH:

- *Malattia*: processo casuale interno e autonomo che trasforma il corpo e l'insieme delle strutture e degli organi. Esperienza interna, non visibile se non nelle componenti che seguono:

- la menomazione (deficit), come danno organico e/o funzionale
- la disabilità (incapacità), come perdita di capacità operative subentrate nella persona a causa della menomazione
- l'handicap (svantaggio), come difficoltà che l'individuo incontra nell'ambiente circostante a causa della menomazione. Problema sociale, conseguenza sociale della malattia.

La persona malata da un punto di vista sociale (ICIDH)

- Lo svantaggio sociale non interessa solo la persona, ma concerne la persona malata nella società.

- Questa classificazione ha però ancora un forte nesso di causalità tra la malattia e la persona, sebbene si possa identificare un noto miglioramento con il passaggio dalla malattia alla persona malata, dal punto di vista medico a quello sociale.

Con l'introduzione del concetto di handicap è stata messa in evidenza in modo forte la rilevanza sociale della disabilità, il suo impatto sulle opportunità di vita della persona e l'importanza di legare la condizione individuale di salute alla tutela dei diritti di cittadinanza.

Critiche all'ICIDH

- L'ICIDH resta quindi una tappa importante nel processo di progressivo affinamento degli strumenti di valutazione di salute e disabilità, anche se nel corso del tempo si sono accentuate, da parte di studiosi e associazioni delle persone con disabilità, critiche importanti alla sua impostazione concettuale e alla sua struttura.
- Cause e correlazioni effettive / La sequenza proposta dall'ICIDH non sempre si presenta completa; una persona può essere menomata senza essere disabile. La barriera dove inizia la disabilità è difficile da porre
- Concetti e espressioni negativi. La descrizione di una persona in termini negativi e di non possibilità ("non sa fare questo, non ha abilità…") crea ulteriori ostacoli ai processi di integrazione.
- Categorie spesso inadeguate nel descrivere le disabilità di anziani, bambini o di persone con disturbi psichiatrici. Si evidenziano difficoltà nell' associare alle persone con disabilità una determinata categoria, a volte perché non esiste alcuna categoria che li includa, altre volte per la possibilità di essere inclusi in più categorie

Critiche all'ICIDH

- Concezione nuova dell'handicap come svantaggio sociale. L' handicap non è considerato un concetto dinamico, infatti in quanto tale può anche essere solo temporaneo.
- Mancanza di ambiti concettuali riferiti a fattori ambientali / Nell'ICIDH si considerano solo i fattori patologici, mentre un ruolo determinante nella limitazione o facilitazione dell'autonomia del soggetto è giocato da quelli ambientali derivati dal contesto.

Verso il modello sociale di interpretazione dell'handicap

- Se la critica all'ICIDH fa emergere che l'handicap risulta dall'interazione fra persone con deficit e le possibili barriere ambientali e mentali che impediscono la completa ed effettiva partecipazione alla società di persone disabili; emerge la necessita di distinguere cosa si riferisce all'individuo e cosa invece ai fattori ambientali e quale sia la risultante dall'incontro delle parti.
- Nasce l'esigenza di un modello concettuale che sappia distinguere chiaramente le componenti del processo sistemico responsabile della produzione dell'handicap.

Situazione di handicap / handicap di situazione

- L'handicap, secondo il modello sociale, si esprime attraverso la non piena partecipazione sociale delle persone alle attività.

- La partecipazione massima è l'auspicabile, tutto ciò che la diminuisce (a causa dell'incontro tra una persona con determinate caratteristiche e un ambiente) crea una situazione di handicap (di svantaggio) o pone in handicap di situazione (particolare).

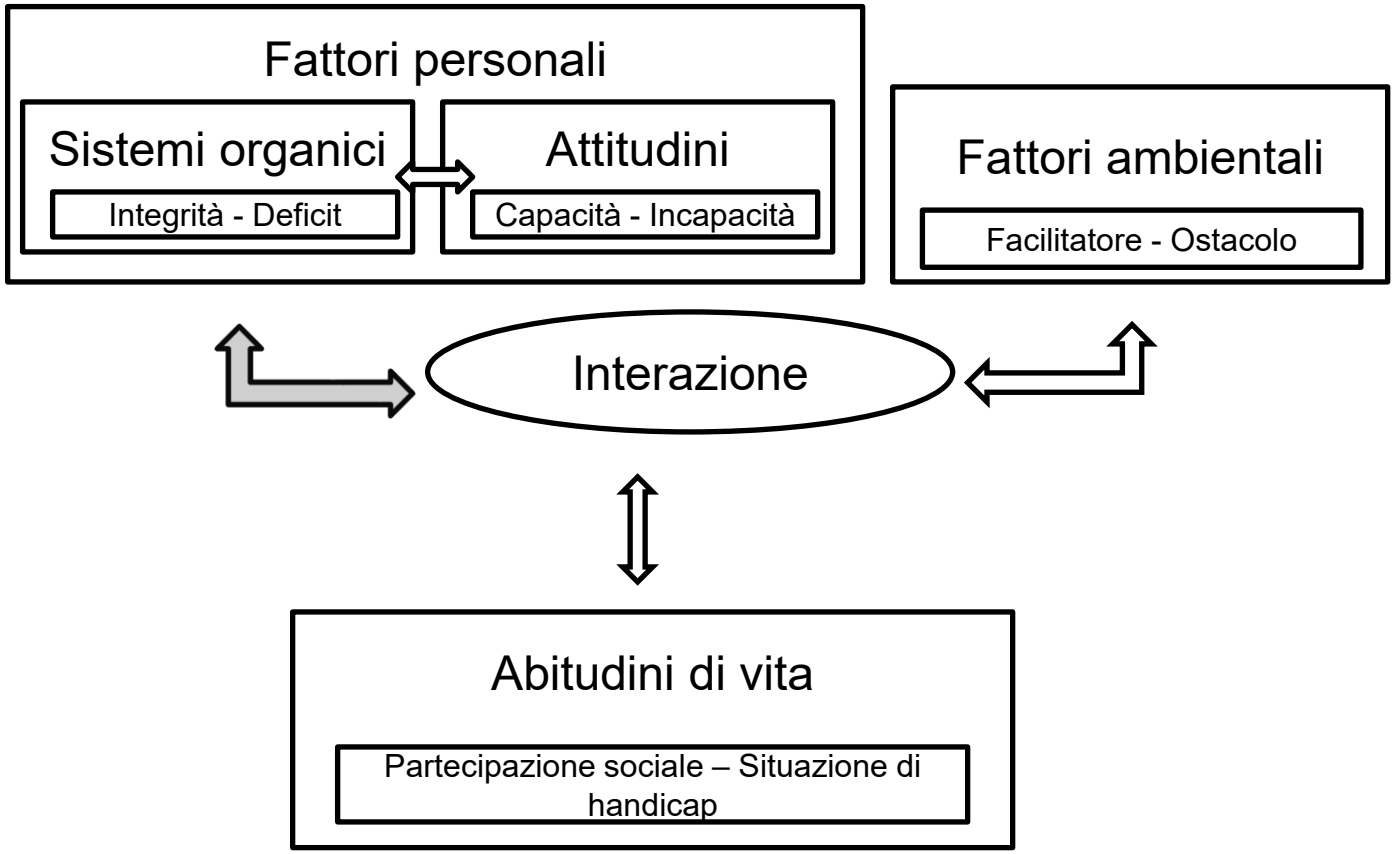
Dalla conseguenze delle malattia al funzionamento della persona, verso l'ICF passando dalla revisione dell'ICIDH

- L'evoluzione verso il modello sociale e le costanti critiche all'ICIDH hanno spinto l'OMS alla revisione dell'ICIDH

- Processo lungo e molto articolato che ha cercato di tenere in considerazioni gli importanti sviluppi nel mondo della disabilità

- Nel percorso che porta all'ICIDH 2 nasce un nuovo modello il **PPH** e una nuova classificazione l'**ICF**

Processo di produzione dell'handicap (PPH)



Bibliografia essenziale

- Gardou C. (2006) , *Diversità, vulnerabilità e handicap, Per una nuova cultura della disabilità*, Erickson
- Gardou C (2016), *Nessuna vita è minuscola*, Mondadori università
- Lepri, C. (2011), *Viaggiatori inattesi. Appunti sull'integrazione sociale delle persone disabili*, Franco Angeli
- Mainardi M. (2010), *Pour une pédagogie inclusive. La pédagogie de l'accessibilisation et les personnes avec des incapacités de développement*. Centre universitaire de Pédagogie curative, Université de Fribourg-CH, n° 15, 345 p.
- Medeghini R., D'Alessio S., D. Marra A., Vadalà G., Valetellina E. (2013), *Disability Studies*, Erickson
- Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W. & Nuzzo A. (2013), *Inclusione sociale e disabilità, Linee guida per l'autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi,* Erickson
- Soresi S., Psicologia delle disabilità e dell'inclusione, 2016, Il mulino